KARLYON ENTERPRISE S.A.

(Soluções Académicas e Empresariais Aplicadas)

Entidade Formadora: ENCORP • Curso de CPD (Desenvolvimento Profissional Contínuo)

Estabilização de pacientes

Avaliação primária ABCDE

Aula 1 de 6 · 1 hora

Coordenador: Sacaita Manuel Inácio

Formação não qualificante, de carácter habilitante

Avaliação primária ABCDE

No final desta aula o formando deve ser capaz de:

Sequência e prioridades da avaliação do doente crítico.

A abordagem ABCDE organiza a avaliação por prioridades: o que mata mais depressa avalia-se e trata-se primeiro. Nesta aula aprende a sequência, os sinais de alerta de cada letra, como comunicar e como reavaliar, e aplica-a a um caso clínico.

Roteiro

1. O que vai aprender nesta aula
2. Porquê uma abordagem sistemática
3. A sequência ABCDE
4. A: via aérea
5. B: respiração
6. C: circulação
7. D: défice neurológico
8. E: exposição e reavaliação
9. Caso clínico: homem de 58 anos com falta de ar
10. Caso clínico: resolução
11. Erros frequentes
12. Pontos-chave
13. Para reflectir
14. Para aprofundar

O que vai aprender nesta aula

No final desta aula será capaz de:

1. Explicar porque é que o ABCDE ordena a avaliação por prioridades de vida
2. Aplicar a sequência A, B, C, D, E a um doente crítico
3. Reconhecer os sinais de alerta de cada letra
4. Decidir quando pedir ajuda e comunicar de forma estruturada
5. Reavaliar o doente depois de cada intervenção

Porquê uma abordagem sistemática

O doente crítico morre, em regra, por falência da **via aérea, da respiração ou da circulação**. O ABCDE dá a todos os profissionais a mesma ordem de trabalho, qualquer que seja o diagnóstico.

- Trata primeiro o que mata mais depressa
- Evita ser distraído pelo problema mais visível (por exemplo, uma fractura) e esquecer a via aérea
- Cria uma linguagem comum na equipa
- Com mais pessoas, avalia-se e trata-se ao mesmo tempo

> **Regra de ouro:** não passe à letra seguinte sem resolver (ou pedir ajuda para resolver) o problema da letra em que está.

A sequência ABCDE

A	B	C	D	E
Via aérea (Airway). Está livre e segura?	Respiração (Breathing). Ventila e oxigena bem?	Circulação (Circulation). Há perfusão suficiente?	Défice neurológico (Disability). Qual o estado de consciência?	Exposição (Exposure). O que não vi por estar vestido?

A: via aérea

Sinal	O que sugere	Primeira acção
Fala normalmente	Via aérea livre (por agora)	Continuar a avaliar
Estridor	Obstrução parcial alta	Pedir ajuda urgente, oxigénio
Gorgolejo	Líquido ou secreções	Aspirar
Ronco	Língua ou tecidos moles	Abrir a via aérea
Silêncio com muito esforço	Obstrução completa	Emergência: pedir ajuda já

> Abra a via aérea com extensão da cabeça e elevação do queixo. Se suspeita de lesão da coluna cervical, use a elevação da mandíbula.

B: respiração

Parâmetro	Referência no adulto	Sinal de alerta
Frequência respiratória	12 a 20 por minuto	8 ou menos, ou 25 ou mais
Saturação de O_2 (SpO_2)	94 a 98%	91% ou menos
Esforço	Respiração calma	Músculos acessórios, tiragem, fala só palavras soltas
Tórax	Expansão simétrica	Assimetria, movimento paradoxal

Atenção: a frequência respiratória é dos sinais que se alteram mais cedo e dos que mais se esquecem de contar. Conte durante um minuto inteiro.

C: circulação

Parâmetro	Normal no adulto	Alerta
Pulso	60 a 100 por minuto	Abaixo de 40 ou acima de 130
Tensão arterial sistólica	Acima de 100 mmHg	90 mmHg ou menos
Enchimento capilar	2 segundos ou menos	Mais de 2 segundos
Pele	Quente e seca	Fria e pegajosa
Diurese	0,5 mL/kg/h ou mais	Menos de 0,5 mL/kg/h

- Hemorragia externa: **compressão directa** imediata
- Colha sangue, obtenha acesso venoso e monitorize

D: défice neurológico

A escala **AVPU** é a forma mais rápida de classificar a consciência:

Letra	Significado	Exemplo
A	Alerta	Olhos abertos, orientado
V	Responde à voz	Abre os olhos quando chamado
P	Responde à dor	Só reage a estímulo doloroso
U	Não responde	Sem qualquer resposta

- Observe as **pupilas**: tamanho, simetria e reacção à luz
- Meça a **glicemia capilar**: abaixo de 4 mmol/L (cerca de 70 mg/dL) trate de acordo com o protocolo

> Qualquer alteração da consciência exige glicemia: é uma causa rápida e reversível.

E: exposição e reavaliação

- Dispa o doente para examinar a pele, as costas e as zonas escondidas: lesões, rash, edemas, sangramento oculto
- Meça a **temperatura**
- Preserve a dignidade: cubra o doente assim que acabar de examinar
- Evite a **hipotermia**: cobertor, ambiente aquecido, fluidos a temperatura adequada
- Em trauma, rode o doente em bloco (*log roll*), com ajuda

> **Reavalie sempre** depois de cada intervenção e sempre que o doente mudar. Em caso de dúvida, volte ao A.

Caso clínico: homem de 58 anos com falta de ar

Dá entrada um homem de 58 anos com dificuldade em respirar há 2 horas. Está sonolento mas responde quando o chamam.

- Frequência respiratória: 30 por minuto
- SpO_2 em ar ambiente: 86%
- Pulso: 124 por minuto
- Tensão arterial: 88/54 mmHg
- Temperatura: 38,9 °C; glicemia capilar: 6,2 mmol/L

Pense antes de avançar: qual é a prioridade? Que letras estão alteradas? O que faria em cada uma?

Caso clínico: resolução

- **A:** fala, via aérea livre por agora; vigiar
- **B:** FR 30 e SpO_2 86%: oxigénio por máscara com reservatório conforme protocolo, posição semi-sentada, pedir ajuda
- **C:** pulso 124 e TA 88/54: sinais de **choque**; acesso venoso, colheitas e fluidos conforme prescrição
- **D:** responde à voz (V); glicemia normal
- **E:** febre sugere infecção; despir e procurar o foco

A combinação de febre, taquipneia, taquicardia e hipotensão levanta a suspeita de **sépsis**: chamar o médico de imediato e administrar tratamento prescrito sem atraso.

Erros frequentes

- Passar à letra seguinte sem resolver a anterior
- Olhar só para os números do monitor e não para o doente
- Não reavaliar depois de uma intervenção
- Demorar a pedir ajuda
- Esquecer a glicemia em doentes com alteração da consciência
- Deixar o doente despido e a arrefecer

Pontos-chave

1. O ABCDE trata primeiro o que mata mais depressa
2. Resolva cada letra antes de passar à seguinte
3. A frequência respiratória é um sinal precoce de agravamento
4. AVPU, pupilas e glicemia avaliam o D
5. Evite a hipotermia e preserve a dignidade em E
6. Reavalie sempre e peça ajuda cedo

Para reflectir

Discuta com um colega ou com o seu orientador:

? Em que situações da sua prática o ABCDE teria mudado a ordem em que agiu?

? Como comunicaria este doente ao médico em 30 segundos?

? Que material deve estar sempre pronto para tratar problemas de A, B e C?

Para aprofundar

Consulte no ENCORP:

→ Avaliação primária ABCDE

→ Sinais vitais: valores de referência no adulto

→ Escala de Coma de Glasgow

PRÓXIMO PASSO

Teste de avaliação

- 10 perguntas de escolha múltipla
- Nota mínima de aprovação: 70%
- Reveja os pontos-chave antes de começar
- Pode repetir o teste as vezes que quiser